看板 档案 B · 家属代记视角 | 记录者随条目标注 | 构建 2026-10-25 | v0.1.0

档案

慢性期（CP） | 转录本 e13a2（典型）

姓名	林雨桐（家属代记：母亲）
性别 / 年龄	女 / 31 岁
概况	CML 慢性期 · e13a2 转录本 · 小学教师 · 由母亲代记
医生告知的分层	ELTS 低危（医生告知）
一句话病史	2020-03 确诊慢性期 CML（e13a2），伊马替尼→尼洛替尼，2026-04 起进入 TFR 停药尝试并密测
本人最在意的	停药后每 1–2 个月抽一次血，等报告那几天最难受；妈妈把每次报告都拍下来存着
本页记录者	家属代记

今日服药卡

停药中（TFR）：无每日服药 | 本机打卡

停药中（TFR）：无每日服药打卡。停药中（TFR）：无每日服药打卡

停药中（TFR）：无每日服药打卡

今天吃了吗 | 一键已服 | 标记漏服 | 模拟本地写失败 | 去服药线

最近 3 天

2026-10-12
无每日服药（停药期） 记录者：家属代记

2026-10-11
无每日服药（停药期） 记录者：家属代记

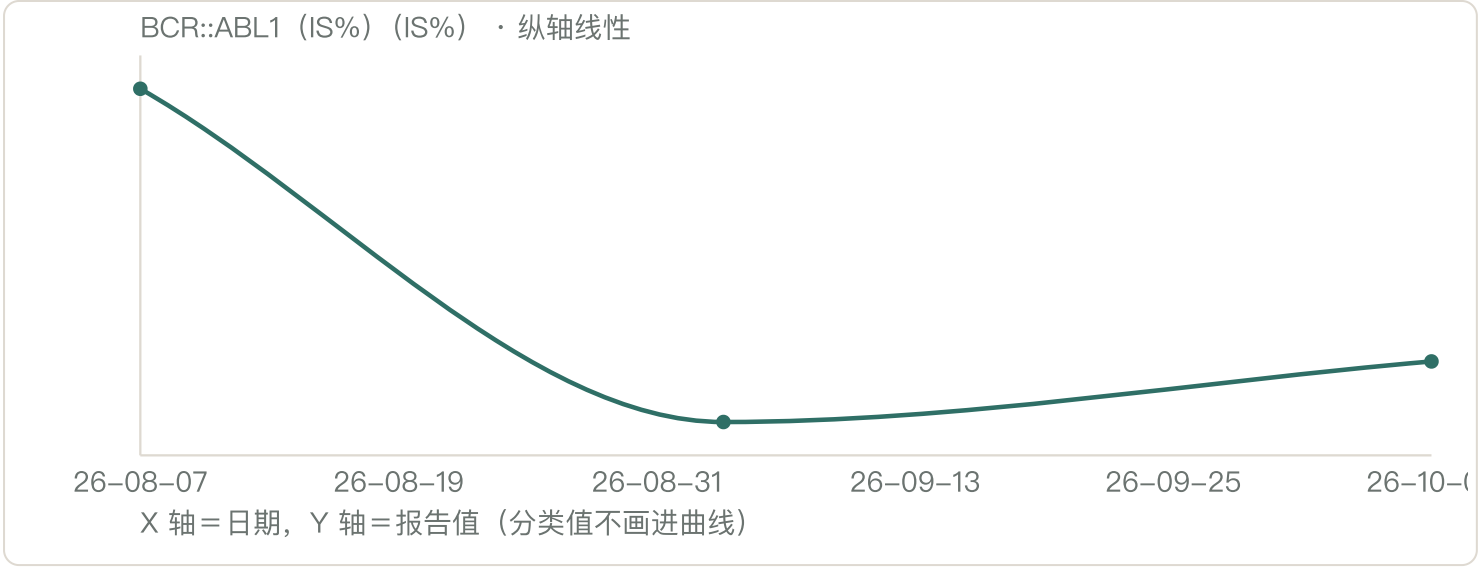
2026-10-10
无每日服药（停药期） 记录者：家属代记

漏服不评判；补服分支规则与来源见服药线「今日打卡」。

分子线速览（最近 3 点）

距下次复查 约 2 个月

日期	BCR::ABL1（IS%）	实验室	IS 标化	灵敏度
2026-08-07	0.003	市一院血液科	是	MR4.5
2026-09-04	0.002	市一院血液科	是	MR4.5
2026-10-08	0.002	市一院血液科	是	MR4.5



四要素（单位 / 实验室 / IS 标化 / 灵敏度）在分子线页逐点列出；相邻点不可比时断开折线。

记一笔复查　去分子线　病情一图秀（叠看几条线）

下次复查安排：血常规 · 每次门诊同时 · 2026–12 上旬（医生安排，仅照抄）

副作用速记（按当前用药过滤）

当前：停药中（TFR）：无每日服药　已隐藏 2 条非当前用药条目

2026–05–02
肌肉骨骼疼痛 withdrawal　记录者：家属代记
停药后腰背和膝盖酸，早上明显

2026–06–11
皮肤瘙痒 withdrawal　记录者：家属代记
晚上痒，抓了会起红印

2026–10–06
（示例）等报告吃不下饭 withdrawal　记录者：家属代记　私密
等报告那几天没什么胃口

记一次不舒服　去副作用日志

只记录不适与处理原文，不出现严重度判读列。

费用速记（按月 × 按药）

不跨药混算　本机新增 0 笔

最近一月（2026–06）自费合计	260 元
全部月份自费合计	1860 元
已记条目数	6 条

只照抄票据金额，不做省不省钱判断。

记一笔　去费用记录

复诊倒计时

2026–10–13

事项	频率 / 书面口径原文	依据	下次时间
血液科门诊 + qPCR	“停药第 7–12 个月：每 2 个月” 来源：医生安排 · 照抄原文，本页不给处置方向	医生安排	2026-12 上旬
血常规	每次门诊同时 来源：医生安排（照抄）	医生安排	2026-12 上旬
若丧失 MMR	“尽快恢复 TKI 并每月监测（由医生决定）” 来源：指南书面口径 · 照抄原文，本页不给处置方向	指南书面口径	—

准备复诊（生成资料包与问题清单）　AI 协助（示例） · 复诊准备：整理资料包大纲

值得报告的信号（HVT–11）

来源未核验　静态事实清单

信号（来源原文口径）	来源	版本	状态
发热：体温 ⩾38.3 ℃，或 ⩾38 ℃ 持续 1 小时以上	中国 CML 诊疗指南（2025 版）· 感染与支持治疗章节	GL–CN–2025	未核验
新发或加重的骨痛 / 关节痛	中国 CML 诊疗指南（2025 版）· 随访章节	GL–CN–2025	未核验
气促 / 呼吸困难 / 静息时也不缓解	中国 CML 诊疗指南（2025 版）· TKI 不良反应章节	GL–CN–2025	未核验
皮肤或黏膜出血点、牙龈出血不易止	中国 CML 诊疗指南（2025 版）· 血液学监测章节	GL–CN–2025	未核验

> 本卡不做个体判断，不给是否就医结论；是否联系医生由你与医生决定。来源未核实 → 标「未核验」。

空态（无信号记录时）：还没有记录信号，卡片只显示上面这份来源清单。

本页 AI 协助

点击后派发 `cml:agent-draft`，提示词只进会话区输入框，不自动发送。

AI 协助（示例）　分子线　TFR 档案　资料导入

手工入口与通道

… 更多

资料导入（候选 → 核对）与临床试验（M4 数据未接入）从本卡「… 更多」和「准备复诊」路径进入。